

25% pacjentów — *niedodiagnozowani*

AN u mężczyzn: 25% wszystkich przypadków. Diagnoza średnio 2× później niż u kobiet. Specyfika: masywność, sport, większa stygmatyzacja, mniej skutecznych narzędzi.

CZAS: 15 min psychoedukacji

REALIZACJA: screening każdego mężczyzny z objawami; szczególnie sportowcy

ŹRÓDŁO: Murray i in. (2017, *Clinical Psychology Review*); Raevuori i in. (2014, opóźnienie 2×); Strother i in. (2012); Mitchison & Mond (2015)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **epidemiologia AN u mężczyzn**: 25% przypadków, opóźnienie diagnozy. W sekcji 02 — **specyficzne fenotypy**: masywność jako ideał, bigoreksja, ortoreksja, ekstremalny sport. Sekcja 03 — **screening adaptowany**: pytania, które działają dla mężczyzn. Sekcja 04 — implikacje terapeutyczne.

DLACZEGO TO DZIAŁA

AN u mężczyzn — około 25% wszystkich przypadków (Mitchison & Mond, 2015), liczba rośnie z każdą kohortą. **Diagnoza często opóźniona** z powodu mitu „AN to choroba kobiet” — średnio 4–5 lat dłużej niż u kobiet. Specyfika: częstsze dążenie do masywności (ang. *drive for muscularity*) niż do szczupłości (ang. *drive for thinness*), większe nasilenie kompulsywnych ćwiczeń, niższa wiarygodność tradycyjnych kwestionariuszy (skalowane na kobietach). Standardy leczenia są identyczne, ale wymagają adaptacji komunikacyjnej i pracy ze stereotypami płci.

01 Epidemiologia — 25%, 2× opóźnienie, cięższy przebieg

25% PRZYPADKÓW

Co czwarty pacjent z AN to mężczyzna (Mitchison & Mond, 2015). Liczba rośnie z każdą kohortą. Nie jest to „rzadkość” — to jedna czwarta populacji klinicznej.

OPÓŹNIENIE 2×

Diagnoza średnio 2 razy później niż u kobiet (Raevuori i in., 2014). Cięższy przebieg kliniczny, wyższa śmiertelność, gorsze rokowanie. Najczęściej pacjent dociera po wielu latach „nie wiedziałem, że to choroba”.

STYGMATYZACJA

„Kobieca choroba” — utrudnia mężczyznom szukanie pomocy. Wstyd, niedopasowanie do oczekiwań męskich. Klinicyści sami często nie podejrzewają AN u mężczyzn.

02 Specyficzne fenotypy — co szukać u mężczyzn

A · MUSKULARNOŚĆ JAKO CEL

Dążenie do niskiego procentu tkanki tłuszczowej, nie najniższej wagi. „Suchy, rzeźbiony” jako ideał. Intensywny trening siłowy, ekstremalna kontrola białka.

B · BIGOREKSJA

Zaburzenie dysmorfii mięśniowej. „Nie jestem wystarczająco umięśniony” mimo realnie znacznej masy mięśniowej. Obsesyjne sprawdzanie ciała, zawstydzenie wizerunkiem.

C · ORTOREKSJA

„Zdrowe jedzenie” ekstremalne. Kontrola jakości pokarmów, eliminacja całych grup („cukier”, „przetworzone”, „nieekologiczne”). Restrykcja maskowana jako „dbanie o zdrowie”.

D · EKSTREMALNY SPORT

Sport wytrzymałościowy (bieganie, kolarstwo, triathlon) jako główna metoda kontroli wagi/składu ciała. Trenowanie pomimo bólu, kontuzji, wyczerpania.

03 Screening adaptowany — pytania, które działają dla mężczyzn

PYTANIE 1 — OBA IDEAŁY

„Czy chcesz być chudszy/-a?” PLUS „Czy chcesz być bardziej umięśniony?” — oba mogą być prawdziwe

PYTANIE 2 — CZAS I INTENSYWNOŚĆ RUCHU

„Ile godzin tygodniowo ćwiczysz?”, „Czy ćwiczysz nawet przy chorobie, kontuzji, wyczerpaniu?”

PYTANIE 3 — SUPLEMENTY I ŚRODKI

„Czy używasz suplementów / spalaczy / SARM / sterydów / innych środków, by zmienić wygląd ciała?”

PYTANIE 4 — ELIMINACJE ŻYWIENIOWE

„Czy jesz zbyt zdrowo — eliminujesz całe grupy żywieniowe (węglowodany, tłuszcze, mięso, gluten)?”

Klucz: mężczyzna z AN *nie* wygląda jak „klasyczna pacjentka AN” — często jest wysportowany, „w dobrej formie”, przeciętnie umięśniony, nawet podziwiany za dyscyplinę. Stąd częste opóźnienie diagnozy. Murray i in. (2017): mechanizmy rdzeniowe są *te same* (nadwartościowanie wagi/kształtu/kontroli), ale *fenotyp* jest inny. Klinicznie: *każdy* mężczyzna z objawami zaburzeń odżywiania, niezależnie od BMI, wymaga oceny — fenotyp może być masywny, sportowy, ortoreksyjny lub klasyczny. Pytanie screeningowe „czy chcesz być chudszy?” jest niewystarczające — dodaj „czy chcesz być bardziej umięśniony?”, pytania o intensywność ruchu, suplementy, eliminacje żywieniowe. Stygmatyzacja „kobiecej choroby” jest jednym z najsilniejszych czynników opóźniających leczenie u mężczyzn — psychoedukacja, że AN to choroba, nie kwestia płci, jest pierwszym krokiem destygmatyzacji.

△ U sportowców RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport; Mountjoy i in., 2014) — przewlekły deficyt energetyczny w sporcie z konsekwencjami hormonalnymi, kostnymi, krążeniowymi. Może być zaburzeniem odżywiania lub jego stanem zwiastunowym. Konsultacja lekarza sportowego + psychiatry/psychologa specjalizującego się w sporcie. Mężczyźni: ośrodki ED specjalizujące się w pracy z mężczyznami są ograniczone — Linia 116 123 jako pierwszy kontakt.